

13 - 03- Les Addictions aux Produits - Pr. Manoudi

(0:02 - 0:41)

Bonjour, aujourd'hui on va voir les addictions aux produits. A la fin de ce cours, vous devez être capable de définir une addiction, définir les différents stades de consommation, citer les critères de dépendance, différencier entre addiction, dépendance physique et psychique, citer les facteurs de risque et de vulnérabilité de l'addiction, citer les facteurs de protection et reconnaître l'action des drogues sur les cerveaux, reconnaître l'effet physique et psychique des drogues les plus consommées et savoir les grandes lignes de prise en charge d'un patient addict. Alors là je vois que vous avez identifié le chaton qui a pris du cannabis.

(0:45 - 1:10)

Alors l'addiction se caractérise ou bien se définit par l'impossibilité répétée de contrôler un comportement et la poursuite de ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. C'est une définition qui est importante qui signifie que l'addict ne peut pas arrêter quand il veut et que l'addiction c'est une maladie. Il existe deux types d'addictions, les addictions comportementales qu'on ne va pas traiter aujourd'hui et les addictions en produit.

(1:11 - 1:31)

Selon l'OMS, l'addiction c'est une perte de la liberté de s'abstenir du toxique et au fil des années plusieurs terminologies ont été utilisées, maintenant on utilise beaucoup plus le terme d'addiction. La dopamine est le neurotransmetteur du plaisir. Depuis toujours, l'homme était à la recherche du plaisir.

(1:31 - 1:55)

Donc à chaque fois, il est à la recherche de nouveautés, de nouveaux produits pour avoir du plaisir, de plus en plus de plaisir. Donc à titre d'exemple, certaines substances ont été utilisées dans un but thérapeutique au début, après leur utilisation a été déviée, comme par exemple la morphine ou bien les benzodiazépines. Le terme addict signifie être esclave de quelqu'un.

(1:55 - 2:21)

C'est un terme qui était initialement réservé aux addictions en substance et on a constaté qu'il y a une analogie entre certains comportements avec le caractère répétitif et compulsif et les pertes de contrôle. C'est-à-dire les addictions en produit et les addictions comportementales ont ces mêmes caractéristiques répétitives, compulsives et pertes de contrôle. Et on a utilisé ce terme d'addiction à certains comportements.

(2:21 - 2:44)

Par exemple, l'addiction à la télévision, aux jeux pathologiques, aux jeux vidéos, l'addiction sexuelle, l'addiction alimentaire, l'addiction à l'ordinateur et les addictions à l'Internet. On différencie l'usage, l'abus et la dépendance. C'est un passage par étapes.

(2:44 - 2:58)

D'abord, on commence par l'usage. L'usage est une consommation de substances psychoactives qui n'entraîne ni complications pour la santé, ni troubles de comportement. Il n'y a pas de conséquences nocives pour les autres ni pour la personne.

(2:58 - 3:12)

Elle n'est pas considérée pathologique. Et on parle de l'usage nocif quand il y a une répétition de consommation avec certains dommages qui sont induits. Dans l'usage, on distingue l'usage expérimental.

(3:13 - 3:23)

C'est un essai qui est ponctuel. L'individu cherche à explorer lui-même les effets de la substance à titre de curiosité. Il veut essayer, il veut savoir qu'est-ce que ça donne comme effet.

(3:24 - 3:38)

En général, c'est une consommation qui est unique et sans lendemain. Malheureusement, le sujet va passer à l'étape suivante, qui est l'usage occasionnel. Au début, il l'a utilisé, il l'a expérimenté, il a vu qu'est-ce que ça donne.

(3:39 - 3:56)

Et après, il va commencer à l'utiliser à chaque fois qu'il y a une occasion, à l'occasion de fêtes par exemple, pour avoir le même effet. Et il rentre dans l'usage convivial. Les produits les plus utilisés dans ce cas sont le cannabis ou l'ecstasy.

(3:57 - 4:18)

L'individu recherche une sensation de plaisir, de bien-être, d'apaisement ou bien de désinhibition dans ces circonstances de fêtes, ces circonstances conviviales. Après, il peut passer à l'usage régulier. Il implique l'existence d'une dépendance psychique et une perte en général du caractère convivial.

(4:18 - 4:34)

Donc il va l'utiliser même s'il n'est pas dans une fête. Et là, il est utilisé pour lutter contre une tristesse ou bien lutter contre une manifestation anxieuse. C'est là qu'il tombe dans l'automédication.

(4:35 - 4:51)

Après, il peut tomber dans l'abus. Alors l'abus, c'est une consommation qui est caractérisée par l'existence de préjudices liés à l'usage occasionnel ou répété sans qu'il y ait dépendance. Donc on n'est pas encore au stade de la dépendance.

(4:51 - 5:19)

Donc la consommation peut avoir des conséquences sur la santé, du sujet santé physique ou psychique ou des conséquences sociales, familiales ou professionnelles. Donc des conflits dans la famille ou bien des conflits dans son milieu de travail. La dépendance, c'est la prise compulsive de drogue malgré la connaissance des effets néfastes sur la santé ou bien sur l'entourage.

(5:20 - 5:44)

Donc le sujet, il est dans l'impossibilité d'arrêter. Il devient dépendant de la drogue. Les addictions produites sont classées dans le DSM-5 qui est la classification statistique des troubles mentaux dont le trouble de l'usage des substances psychoactives.

(5:44 - 6:00)

Elle est définie par l'utilisation inadaptée d'une substance conduisant à une dégradation ou à une détresse cliniquement significative. Donc on a plusieurs critères. Le premier critère, l'incapacité de remplir des obligations majeures au travail, à l'école ou à la maison.

(6:01 - 6:14)

Il passe tout son temps à chercher de la drogue. Donc le deuxième critère, l'usage dans des situations dans lesquelles celui-ci est physiquement dangereux. La conduite par exemple ou bien la manipulation de machines.

(6:14 - 6:37)

L'usage poursuivi malgré des problèmes sociaux ou interpersonnels persistants ou récurrents causés ou aggravés par les effets de la substance. Donc malgré la connaissance des conséquences négatives. Le quatrième critère, c'est l'effet de tolérance qui est défini par le besoin d'augmenter notamment les quantités de substances pour atteindre l'intoxication ou les effets désirés.

(6:38 - 6:50)

Donc un joint ne se fait plus, il passe à deux joints, après deux ne se fument plus, il passe à trois et ainsi de suite. L'effet diminue lors de l'usage continu bien sûr. Donc à chaque fois il doit augmenter les doses pour avoir le même effet.

(6:52 - 7:05)

Il y a ensuite l'effet de sevrage. C'est le syndrome de sevrage qui caractérise de chaque substance. Donc à l'arrêt de chaque substance, surtout quand il y a un arrêt brutal, le sujet va ressentir des symptômes.

(7:05 - 7:20)

Il y a des substances qui vont donner beaucoup plus de symptômes psychophysiques et d'autres vont donner beaucoup plus de symptômes physiques que psychiques. La substance consommée pour soulager ou éviter les symptômes de sevrage. Et pour éviter ce symptôme de sevrage, le patient doit reconsommer.

(7:21 - 7:36)

Substances prises en quantité plus importante et pendant une période plus longue que prévue. Avec un désir persistant, effet infructueux pour arrêter ou contrôler l'usage de la substance. Donc il est dans l'impossibilité d'arrêter malgré ses efforts.

(7:37 - 7:53)

Beaucoup de temps passait à se procurer de la substance, à la consommer ou à la récupérer, ou à récupérer de ses effets. Neuvième critère. Importantes activités sociales, professionnelles ou de loisirs sont arrêtées ou réduites à cause de l'usage de la substance.

(7:54 - 8:04)

Il consacre tout son temps à l'usage de la substance. Dixième critère. L'usage de la substance poursuivi malgré l'existence de problèmes physiques ou psychologiques persistant au recurrent.

(8:05 - 8:20)

Le onzième critère qui a été ajouté dans le DSM 5 est l'existence d'un craving ou d'un désir fort ou d'une pulsion à consommer. C'est cette envie de consommer. C'est surtout en rapport avec la dépendance psychique.

(8:21 - 8:35)

Si on a deux à trois critères, on parle d'une dépendance modérée. Si on a quatre critères au plus, on parle d'une dépendance sévère. Dans la dépendance, on différencie la dépendance physique.

(8:36 - 8:49)

Certains produits vont entraîner une dépendance physique qui se traduit par des symptômes physiques lors de la privation et qui traduisent l'état de manque. Donc ça dépend des produits.

Par exemple, l'héroïne.

(8:50 - 9:05)

À l'arrêt de l'héroïne, les patients vont présenter beaucoup plus de douleurs et des douleurs qui sont très intenses. À l'arrêt de l'alcool, les patients peuvent présenter des tremblements. C'est pour ça que des fois, les alcooliques, dès le réveil, commencent à consommer.

(9:05 - 9:16)

On les voit dès le réveil, ils ont des tremblements au niveau de la main. Les barbituriques et les benzodiazépines, à l'arrêt brutal, peuvent donner des convulsions et même des crises d'épilepsie. C'est très important.

(9:17 - 9:28)

C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter brutalement les benzodiazépines. On fait une dégression progressive. Même l'alcool, quand le patient est en sevrage, il faut le couvrir par des benzodiazépines.

(9:29 - 9:53)

On va voir, parce que l'alcool agit sur les mêmes récepteurs benzodiazépiniques. Alors ces symptômes peuvent être accompagnés de troubles de comportement. La dépendance psychique, elle se manifeste par un sentiment de malaise, d'angoisse, de dépression et une impossibilité de résister aux besoins de consommer la substance.

(9:53 - 10:10)

C'est ce qu'on appelle le gravine, cette envie d'aller chercher la substance pour soulager la tension psychique. Et bien sûr, le soulagement est ressenti lors de la consommation avec un sentiment de perte de contrôle. La dépendance psychique est la plus difficile à traiter.

(10:13 - 10:24)

En résumé, il existe plusieurs stades de consommation. Comme on a dit, le patient va passer par l'expérimentation. Quand il va expérimenter, il va bien sûr voir l'effet que ça donne.

(10:24 - 10:43)

Ça va lui plaire, bien sûr, parce qu'au début ça donne un effet d'euphorie, un effet de bien-être, un plaisir. Et bien sûr, il va le recommencer à chaque occasion, pendant les fêtes par exemple, pour avoir l'effet de désinhibition. Après, il va tomber dans l'abus.

(10:43 - 10:59)

Il va l'utiliser même quand il n'y a pas de fête, quand il ne se sent pas bien, dans le cadre d'une automédication. Et par la suite, il peut tomber dans la dépendance psychique et physique. C'est l'étude dont on a parlé la dernière fois.

(11:01 - 11:24)

La prévalence de l'abus de substances sur la population marocaine, selon cette étude faite en 2003, a été évaluée à 3%. La prévalence de la dépendance aux substances à 2,8%. Plus en détail, la dépendance de l'alcool actuel était à 1,4%.

(11:24 - 11:35)

L'abus d'alcool actuel, 2%. L'utilisation de drogue dans les 12 derniers mois, 4,1%. La dépendance actuelle à une ou plusieurs substances, 2,8%.

(11:35 - 11:57)

Et l'abus de substances actuelles à 3%. Un taux de mortalité très élevé, à l'échelle de la population générale mondiale, estimé à 0,5% à 3,5% par an. Quatre causes principales de mortalité.

(11:58 - 12:33)

Il y a l'infection par le VIH, surtout lorsque les patients vont échanger le matériel d'utilisation des drogues injectables, quand ils vont échanger les seringues, surdosage, donc l'overdose, le suicide, et les infections hors-sédate, notamment les infections hépatiques. Les facteurs de vulnérabilité et les facteurs de risque. Il y a trois types de facteurs et c'est l'interaction entre ces trois types de facteurs qui va faire tomber le patient dans l'addiction.

(12:34 - 12:58)

Donc il y a des facteurs qui sont liés au produit, des facteurs individuels en rapport avec la génétique et la biologie et les facteurs psychiatriques du patient et des facteurs en rapport avec l'environnement, des facteurs externes. C'est l'interaction entre ces trois facteurs qui va faire tomber les sujets dans l'addiction. Dans les facteurs liés au produit, il y a en premier le pouvoir addictif des produits.

(12:59 - 13:12)

Donc il y a des produits qui, dès la première consommation, sont très addictifs. Ils vont faire tomber rapidement le sujet dans l'addiction, le tabac par exemple. C'est pour ça qu'il est le plus répandu.

(13:12 - 13:38)

Il y a des produits qui vont entraîner plus de complications sanitaires, psychologiques et sociales comme par exemple la cocaïne et l'alcool. Et à cause de ces complications, le patient va reconsommer pour diminuer ces complications. Et il y a des produits qui vont entraîner des complications surtout sociales par exemple la marginalisation, la désocialisation, la délinquance.

(13:38 - 13:55)

C'est le cas par exemple de l'héroïne ou bien le krach ou bien le cas des solvants. Et le sujet, pour ne pas lier à ces complications, il va reconsommer et il rentre dans un cercle vicieux. Donc ça, c'est des facteurs qui sont liés au produit lui-même.

(13:56 - 14:24)

Les facteurs individuels, il y a les facteurs génétiques qui sont dus à l'influence sur le métabolisme et les effets des drogues. C'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas tous égaux vis-à-vis de l'alcool, des drogues. Donc il y a des sujets qui vont être rapidement addicts, vont présenter rapidement des complications et d'autres non.

(14:25 - 15:20)

Il y a les facteurs biologiques, donc à cause du neurotransmetteur du plaisir qui est la dopamine des sujets qui vont être plus sensibles au stress et aux événements stressants que d'autres. Et il y a les traits de personnalité, notamment le faible estime de soi, la timidité, l'autodépréciation, les réactions émotionnelles excessives, les difficultés à réagir face à certains événements, les difficultés à avoir des relations sans stables, les difficultés à résoudre les problèmes interpersonnels, des facteurs en rapport avec les tempéraments, les sujets qui ont un niveau élevé de recherche de sensations. Donc il y a des sensations, des jeux ou bien des sports qui donnent des sensations et les sujets vont chercher des sensations de plus en plus fortes.

(15:20 - 15:49)

Et les sujets qui sont à la recherche de nouveautés, explorer les choses, chercher à trouver des plaisirs dans des choses nouvelles. Les faibles événements du danger, les sujets qui ont un faible niveau de sociabilité. Tous ces facteurs, il faut les chercher par l'entretien, quand on fait l'entretien addictologique pour pouvoir travailler avec le patient et pour pouvoir les corriger ou bien les traiter.

(15:51 - 16:37)

Et il y a les troubles de comportement, les sujets qui ont de l'impulsivité, de l'agressivité, des conduites et des interactions sociales à problème. Les sujets qui ont des troubles affectifs, les dépressives, les patients qui ont des dépressives, des troubles de l'humeur, des idées suicidaires, des facteurs qui sont en rapport avec les événements de vie, les deuils, les ruptures, les maltraitances, les abus sexuels à l'enfance, les absences de domicile fixe, la présence de

maladies somatiques graves. Donc le sujet va commencer à utiliser des drogues pour diminuer la souffrance ou bien la douleur.

(16:37 - 16:56)

L'existence de comorbidités psychiatriques type troubles anxieux, troubles du sommeil, troubles des conduites alimentaires et troubles psychosomatiques. Donc il va commencer à utiliser des substances dans le cadre de l'automédication. Troisième type de facteurs, c'est les facteurs liés à l'environnement.

(16:56 - 17:41)

Donc les facteurs extérieurs, les liens familiaux éclatés, la violence dans la famille, les conflits dans la famille, les maladies psychiatriques dans la famille, les événements de vie traumatiques, le style d'éducation parentale trop négligeant ou bien rejetant ou bien les familles qui ne tolèrent pas la différence. Il y a aussi les facteurs en rapport avec les amis, donc la pression du groupe, surtout chez les adolescents. L'adolescent va se trouver obligé de faire comme les autres, sinon il va être rejeté du groupe.

(17:41 - 18:17)

D'autres facteurs externes, notamment la perte des repères sociaux, le chômage, l'exclusion scolaire, l'absentéisme, les phobies scolaires, la marginalisation. En résumé, ce sont des facteurs internes psychologiques, génétiques, neurobiologiques associés à des facteurs environnementaux externes qui vont pousser le sujet à la première expérimentation des drogues. L'adolescent va trouver un effet positif et il va passer à l'abus, et de l'abus, il va passer à la dépendance.

(18:18 - 18:56)

Comme il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs protecteurs, notamment les niveaux élevés d'intelligence, les capacités de résoudre les problèmes, les compétences sociales efficaces, un niveau satisfaisant d'estime de soi, un soutien familial adapté et l'existence d'une compétence scolaire. Comment les drogues vont agir au niveau du cerveau ? Tous les drogues vont augmenter la quantité de dopamine disponible dans une zone du cerveau qu'on appelle le circuit de récompense. Il y a trois modes d'action sur la dopamine.

(18:56 - 19:20)

Soit ils vont imiter la dopamine, soit ils vont augmenter la sécrétion, soit ils vont inhiber la recapture. Il y a deux types de plaisirs. Il y a les plaisirs naturels, donnés par l'alimentation par exemple, par les relations affectives, par les relations sexuelles, et il y a les plaisirs artificiels.

(19:21 - 20:05)

Donc on va voir que les sujets addicts, quand ils commencent à consommer des drogues, ils vont avoir plus de plaisir que le plaisir donné par les substances naturelles. Et donc ils vont délaisser les substances naturelles au profit des plaisirs artificiels qui ont des conséquences sur la santé physique et psychique et sociale. Alors si vous voyez ici la synapse dopaminergique dans le circuit de récompense, on voit qu'on a déjà des récepteurs pour les différentes drogues.

(20:05 - 20:47)

Donc on a le récepteur nicotinique qui est fait normalement pour la cisylcoline, on a le récepteur cannabinoïde qui est fait pour l'endocannabinoïde, le récepteur GABA qui est fait pour le GABA, le récepteur morphinique qui est fait pour les endorphines. Ces récepteurs sont utilisés par les plaisirs naturels, notamment la nourriture, les rapports affectifs, le sport, les rapports sexuels, et leur stimulation va donner une augmentation de la dopamine dans la fente synaptique. Cette augmentation de la dopamine, comme vous voyez ici, il est à un niveau modéré.

(20:47 - 21:35)

Cette augmentation de la dopamine qui est l'hormone, le neurotransmetteur du plaisir, va donner un bien-être. Ce bien-être est mémorisé au niveau de l'amygdale, le sujet va mémoriser l'effet positif de ses plaisirs naturels, ce qui va le pousser, ce qui va le motiver à répéter ses comportements, à répéter ses plaisirs naturels. Alors là, on voit les différentes drogues, comme on l'a dit, elles agissent soit par l'augmentation de la libération de la dopamine, soit par l'inhibition de la recapture.

(21:36 - 22:06)

Là, le tabac, il va utiliser le récepteur nicotinique, le cannabis, il va utiliser le récepteur endocannabinoïde, l'alcool va utiliser le récepteur GABA, l'héroïne va utiliser les récepteurs morphiniques. Pour la stimulation de ces récepteurs par ces drogues, va augmenter la dopamine. Vous voyez ici la différence du premier schéma, la dopamine, elle est augmentée à un niveau très élevé.

(22:06 - 22:54)

D'autres substances, notamment le cannabis, la cocaïne, l'ecstasy et l'amphétamine, ils vont inhiber la recapture de la dopamine et ils vont donner le même effet, l'augmentation de la dopamine au niveau de la fente synaptique. Cette augmentation très importante de la dopamine donnée par les drogues à l'opposé des plaisirs naturels, il va donner un bien-être extrême. Et le sujet, bien sûr, il va mémoriser au niveau de l'amygdale, cet effet émotionnel, cet effet positif des drogues, ce qui va l'encourager, ce qui va le motiver, ce qui va le pousser à les reconsommer encore une fois pour avoir le même effet positif.

(22:54 - 23:17)

Et bien sûr, il va diminuer la consommation et sa motivation par rapport aux autres plaisirs naturels, la nourriture, les rapports sexuels et les autres plaisirs naturels va diminuer. Là, le schéma montre, c'est comme si on est fait pour être addict. On est prédisposé à être addict.

(23:20 - 23:44)

Plus un objet ou une situation sont récompensants, plus rapidement ils sont mis en mémoire pour être recherchés et répétés. Au niveau de l'amygdale, il y a une perception de la valeur émotionnelle et un réservoir des mémoires émotionnelles. Et au niveau de l'hypocampe, on a la mémoire des faits et des lieux.

(23:44 - 24:08)

Comme on a dit, le sujet quand il va commencer, il va sentir un bien-être, un plaisir, de l'euphorie. Cet effet émotionnel, il va le mémoriser au niveau de l'amygdale. Et les faits des lieux, là où il a consommé, les personnes avec qui il a consommé, il va le mémoriser au niveau de l'hypocampe.

(24:08 - 24:40)

Donc à chaque fois qu'il va passer par exemple devant un café, où il a consommé la première fois ou bien la dernière fois, à chaque fois où il va rencontrer un copain avec qui il a consommé, à chaque fois qu'il va passer devant un bar, il va avoir cette gravine, cette envie d'aller consommer. Les drogues viennent se greffer sur les voies du plaisir qui existent déjà, donc les voies naturelles. Elles vont constituer un véritable leurre pharmacologique.

(24:40 - 25:06)

Elles prennent la place des neuromédiateurs naturels. Comme on a dit, c'est comme si on est fait pour être addict. Donc à la différence des addictions comportementales qu'on ne va pas traiter, là elles sont expliquées par la perte du contrôle des mécanismes naturels de recherche du plaisir et d'évitement de la souffrance, et de gestion des émotions positives et négatives.

(25:06 - 25:49)

Donc ces sujets-là, ils n'ont pas les bonnes manières pour contrôler les émotions négatives et positives, ni pour chercher du plaisir autre. On différencie l'action des drogues sur le cerveau par trois types d'actions. Il y a les dépresseurs du système nerveux central, les opiacés, les anxiolytiques, les barbituriques, il y a les stimulants, les amphétamines, la cocaïne, la caféine, la nicotine, et il y a les perturbateurs, le cannabis, les hallucinogènes, l'alcool, les solvants et les dérivés anticholinergiques.

(25:51 - 26:07)

On va un petit peu détailler les plus fréquents. Donc le cannabis, il existe sous trois formes, la

feuille, la résine et l'huile. Le nom est différent en fonction des pays.

(26:07 - 26:54)

L'herbe est pratiquement remplacée par la résine parce qu'elle est plus facile à être transportée, mais on connaît un revain d'intérêt de la feuille avec l'autoculture. La résine est la plus utilisée et sa teneur en 9 THC, qui est le produit actif du cannabis, il diffère selon les pays. Alors l'huile, c'est une pâte qui est liquide verte foncée, voire noire, obtenue en mélangeant de la résine avec un solvant.

(26:55 - 27:26)

Elle peut contenir de 60 à 80 % de THC. Environ 147 millions de personnes consomment du cannabis, soit 2,5 % de la population mondiale, contre 0,2 pour la cocaïne et 0,2 % pour les opiates. Comme le tabac, la résine de cannabis, elle comprend 400 composants, mais un seul est à l'origine des effets psychotropes, des effets addictifs.

(27:27 - 27:45)

C'est le delta-9-tetrahydrocannabinol. Elle a un métabolisme hépatique et une élimination rénale, donc c'est pour ça qu'on peut le doser au niveau des urines. Elle a une demi-vie de 8 jours et le plus souvent, elle est utilisée fumée.

(27:46 - 28:44)

Là, les moyens de dépistage biologique, donc au niveau des urines, on peut le trouver jusqu'à une semaine si on a une consommation occasionnelle, si la consommation est régulière, jusqu'à 21 jours. Bien sûr, le cannabis est utilisé pour ses effets positifs, notamment les effets euphorisants, les émotions conviviales lors des fêtes, la modification de la conscience, le sujet est dans un état autre, dans un état différent, le soulagement du stress, à la recherche d'une relaxation, les sujets peuvent chercher l'amélioration du sommeil, mais bien sûr, ça donne des effets somatiques et psychiques. Les effets somatiques peuvent être les mêmes que ceux du tabac, donc il peut même donner des cancers branchiques et auto-rénaux laryngés.

(28:45 - 29:14)

Il y a des études qui ont montré, même quand il n'est pas associé au tabac, il peut donner aussi des cancers. Il y a aussi des effets cardiovasculaires, il y a des céphalées, il peut donner aussi des faibles dépressions respiratoires. Des problèmes neuropsychiques divers, notamment des états d'angoisse aiguës qui peuvent aller jusqu'à l'attaque de panique, des agitations psychomotrices, des hallucinations, des réactions paranoïaques.

(29:14 - 29:58)

C'est l'effet parano, la méfiance, l'impression qu'on parle d'eux, l'impression qu'on cherche à leur faire du mal, l'impression qu'ils sont suivis. Il peut même entraîner des états subconfusionnels, confusionnels, avec des atteintes des fonctions cognitives, notamment des troubles de l'attention, des troubles de mémoire, des troubles de la concentration, des mauvais réflexes en situation d'urgence, l'utilisation de machines ou la conduite automobile, et des mauvaises coordinations de mouvements. L'intoxication ou l'ivresse, elle peut se manifester dans les deux heures qui suivent la prise, avec des effets psychosensoriels qui peuvent durer de trois à huit heures, et des perturbations cognitives jusqu'à 24 heures.

(30:00 - 30:54)

Elle se manifeste par l'euphorie, par des modifications sensorielles, des perceptions qui peuvent aller jusqu'à l'illusion ou bien les hallucinations, des perturbations cognitives, des troubles de la coordination motrice, des difficultés à effectuer des tâches complexes. Aussi des symptômes physiques, notamment des malaises, des tremblements, des difficultés respiratoires, des signes cardiovasculaires, des signes digestifs, et des hallucinations, des signes psychiques. Un syndrome beaucoup plus fréquent avec le cannabis, mais qu'on peut aussi trouver avec les autres addictions, et qui constitue une complication chronique, suite à la consommation de cannabis, c'est ce qu'on appelle le syndrome amotivationnel.

(30:54 - 31:37)

Donc c'est un syndrome à long terme, qui va se manifester par des difficultés de l'attention, de l'activité, d'une asthémie intellectuelle et physique globale, des perturbations cognitives, des troubles de mémoire, de concentration, de l'attention, des flous de la pensée, des difficultés de concentration et de mémoire, et des rétrécissements de la vie relationnelle, de l'isolement. Le patient est un petit peu déficitaire, et ce syndrome pose le diagnostic différentiel avec la schizophrénie, surtout la schizophrénie déficitaire. Cannabis dépression et anxiété est une association qui est fréquente.

(31:37 - 32:12)

Le cannabis a un effet dépressogène qui est modeste, et qui est majoré surtout s'il est consommé à un stade précoce, ou bien s'il y a des consommations sévères. Les troubles anxieux peuvent survenir lors du syndrome de sevrage, ou lors d'une consommation chronique, le plus souvent sous forme d'attaque de panique, un syndrome de dépersonnalisation, ou bien de déréalisation. Le cannabis donne aussi des troubles psychotiques, donc secondaires à ce toxique.

(32:12 - 32:39)

Le premier et le plus fréquent est l'accès psychotique aigu, qu'on appelait avant bouffée délirante aiguë. Il peut aussi donner des hallucinations visuelles plus qu'auditives isolées. Ce syndrome

psychotique peut être résolu rapidement sous traitement neuroleptique, les sentiments persécutifs, défunts, ou un effet paranoïaque peut persister.

(32:42 - 33:06)

Le syndrome de sevrage, c'est les symptômes qui apparaissent à l'arrêt de la consommation. Il peut débuter après 24 heures d'abstinence, avec un maximum entre 2 à 4 jours, et il diminue en général après 7 jours. Donc le patient a besoin juste d'un soutien pendant cette semaine pour dépasser ce cap de syndrome de sevrage.

(33:09 - 33:39)

Il se manifeste par des signes fréquents et des signes moins fréquents. Parmi les signes fréquents, on a la colère, l'agressivité, l'anorexie, l'irritabilité, des angoisses, une incapacité à rester en place, des insomnies et des rêves, ou bien des cauchemars étranges. Les signes moins fréquents, c'est des frissons, des symptômes dépressifs, des douleurs abdominales, des tremblements, ou bien des sueurs.

(33:44 - 36:01)

Le deuxième type d'addiction qu'on va traiter, qui est aussi fréquent, c'est l'addiction aux benzodiazépines et aux barbituriques. On la retrouve surtout chez les femmes et les adolescents qui ont des symptômes, des antécédents dépressifs ou bien des antécédents de troubles anxieux. Les patients vont rechercher, bien sûr, un effet positif qui est la sédation de l'anxiété, la relaxation, l'amélioration du sommeil, mais bien sûr, ces produits ont des effets sur la mémoire et ils peuvent entraîner des tremblements.

A long terme, on voit des symptômes physiques, notamment la coordination motrice, le ralentissement de l'idéation, des troubles de la concentration, des mémoires et des troubles du caractère. L'intoxication aiguë peut entraîner de l'euphorie, de la désinhibition psychomotrice, une labilité émotionnelle jusqu'à la confusion mentale, des crises convulsives aussi, qui peuvent avoir des conséquences graves, des troubles cardiovasculaires et même de la détresse respiratoire et le coma. Le syndrome de sevrage, à l'arrêt des benzodiazépines, il peut se revenir 12 heures à 3 jours après l'arrêt.

Il va se manifester par une réactivité, une anxiété, une confusion mentale et des crises convulsives. Donc c'est la chose à redouter, c'est pour ça qu'il faut diminuer progressivement les benzodiazépines. Jamais un arrêt brutal.

Les troubles neurovégétatifs, un sommeil agité, une anorexie, des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, une faiblesse musculaire. Les solvants volatils sont beaucoup plus utilisés par les enfants et les adolescents, ayant des problèmes sociaux et des facteurs environnementaux négatifs. Certaines professions sont exposées et certains milieux surtout

défavorisés, notamment les professions, il y a les mélusiers par exemple.

(36:03 - 36:42)

Les effets négatifs, c'est l'ivresse, les vertiges, l'euphorie, la hallucination, puis le tremblement et la taxie. A long terme, ils peuvent entraîner une altération de l'état général avec perturbations sévères du jugement, ce qui peut entraîner des actes médico-légaux et une dissocialisation importante. Les opiacés, alors les opiacés, ils vont donner beaucoup plus une dépendance physique et psychologique qui est forte et d'installation rapide.

(36:43 - 37:07)

La tolérance, elle est faible avec ces produits. La consommation se fait soit par voie sniffée, soit fumée ou injectée. Parmi les effets cliniques aigus, on note au début, les sujets vont rechercher cet état de flash.

(37:08 - 37:54)

C'est une réaction brutale, intense d'euphorie. Après ce flash, le sujet éprouve un état de bien-être apaisant, toutes les angoisses, et cela va donner une incapacité à se concentrer. Sur le plan physique, il y a un réchauffement cutané, un pruri, des tachycardies, de l'hypotension, des hyperglycémies, des nausées et des vomissements.

Après, on peut avoir des complications psychiatriques, donc diverses complications psychiatriques. Il peut y avoir comme complications graves, mortelles, l'overdose, en cas d'intoxication aiguë. On peut aussi trouver des complications somatiques qui peuvent être mortelles.

(37:55 - 38:27)

Surtout s'ils sont compliqués, d'odème aigu du poumon, d'odème cérébral, des chocs cardiaques. On peut aussi trouver des complications sociales, des actes médicaux légaux, des homicides, des vols, des agressions. Les OPC donnent aussi à l'arrêt un syndrome de sevrage qui va se manifester par des agitations anxieuses, de l'armohamon, de baillement, des frissons, des sueurs, des nausées, médias bilatérales, une insomnie totale.

(38:27 - 38:45)

Et les heures qui suivent sont caractéristiques aux OPC des douleurs abdominales, lombaires, thoraciques, des douleurs des membres. Ces douleurs sont très intenses. C'est pour ça qu'au niveau du traitement, on va voir qu'on va donner des ontologies, qu'on va donner des antispasmodiques à forte dose.

(38:45 - 39:40)

On trouve aussi de la diarrhée, des vomissements et de la confusion. La cocaïne est extraite de la feuille du coca. Elle entraîne une dépendance psychologique très forte et une dépendance physique qui peut exister mais elle est faible à la différence de l'héroïne.

On a aussi des complications psychiatriques. L'intoxication peut aussi entraîner de l'overdose qui peut engendrer la mort. On a aussi des complications somatiques caractéristiques de la cocaïne surtout les ulcérations et les perforations de la cloison nasale parce que la cocaïne est beaucoup utilisée, sniffée.

(39:44 - 43:14)

Les hallucinogènes, le LSD c'est un hallucinogène très puissant. Ses effets se manifestent par une dépersonnalisation, des troubles du cours de la pensée, du langage, une désorientation temporo-spatiale, un état de rêve artistique, des troubles chimiques congruents au délire et des troubles du comportement avec risque de passage à l'acte hétéroagressive, une dépendance psychique qui est très importante. Les amphétamines et l'ecstasy utilisées surtout par les adolescents lors des fêtes, dans des événements ou bien pour rechercher cet effet de plaisir lors des moments de convivialité le mode le plus fréquemment utilisé c'est des comprimés qu'on prend par voie buccale.

Alors l'effet recherché surtout pendant ces moments-là c'est la lutte contre la fatigue, la désinhibition, la stimulation l'euphorie pour faire la fête et bien sûr ça donne des dépendances psychologiques avec des manifestations physiques et même parfois des troubles cardiaques et de la déshydratation qui peuvent être graves. Il y a un risque d'accident psychiatrique grave qui va se manifester par un délirium et même par des troubles psychotiques des troubles de l'humeur, des troubles anxieux type d'attaque de panique et il y a bien sûr à cause des manifestations physiques des complications physiques et des complications psychiatriques un risque de décès. Le but de la prise en charge de ces addictions d'abord c'est d'améliorer la santé physique et psychique, on a vu que la plupart des addictions donnent des signes physiques et psychiques, améliorer la relation sociale et familiale, la réduction des comportements à risque et une insertion professionnelle.

C'est une prise en charge médicale, psychologique, psychiatrique et sociale. On utilise ce qu'on appelle des entretiens motivationnels c'est des entretiens qui se font avec des questions ouvertes où le patient va répondre par son ressenti ce qu'il pense, comment il voit les choses qu'est-ce qu'il redoute, ses craintes quand il se projette dans l'avenir, comment il voit les choses, comment ils vont s'améliorer ou bien comment ils vont s'aggraver. Donc des questions ouvertes, alors au contraire des questions fermées pour lesquelles le patient va répondre par oui ou non.

Donc là on laisse le patient s'exprimer. L'hospitalisation elle est indiquée en cas de dépendance sévère en cas d'affection somatique associée à des troubles psychiatriques, en cas de risque suicidaire, en cas de désocialisation ou bien d'isolement et en cas de chèque de sevrage

ambulatoire. Bien sûr il y a une prise en charge en aiguë c'est la prise en charge des complications aiguës, graves qui peuvent engendrer le pronostic vital notamment les accès psychotiques aiguës, les syndromes confusionnels et les syndromes de sevrage et d'overdose.

(43:14 - 43:58)

L'hospitalisation peut nécessiter une hospitalisation en réanimation ou en milieu psychiatrique et bien sûr il faut faire un bilan médico-psycho-social. Par rapport à le sevrage thérapeutique du cannabis quand on propose au sujet ou bien quand le sujet est motivé et il veut arrêter donc surtout pendant la première semaine il faut l'aider pour qu'il passe la première semaine du syndrome de sevrage surtout par des traitements. Il n'y a pas de traitements spécifiques pour les drogues donc il y a des traitements qui peuvent aider le patient à dépasser surtout la phase de sevrage au début.

(43:59 - 48:00)

Donc on préfère donner pour améliorer le sommeil, pour diminuer l'anxiété de la tharax. Parce que si on donne des benzodésipines le patient va sortir d'une addiction et tomber dans une autre. Donc pour les patients addicts on évite les benzodésipines.

On donne aussi pour améliorer le sommeil du téralène un antidépresseur, le remérant qui est beaucoup plus utilisé dans ces cas, qui va améliorer surtout le sommeil. Et s'il n'y a pas d'amélioration du sommeil et de l'anxiété avec ces produits on peut passer à un neuroleptique sédatif qui est le nausinson ou bien le tertion. Quand on a les deux addictions, cannabis et tabac, donc bien sûr on va proposer les deux mais on commence par souvent on va pratiquer à distance l'arrêt du tabac par rapport à l'arrêt du cannabis.

Et on va utiliser des substances nicotiques pour le tabac ou bien du bupropion, le zibon qui est utilisé pour le sevrage du tabac. Quand on a une addiction au cannabis et aux benzodésipines bien sûr il faut d'abord respecter les règles de la prescription des benzodésipines pour ne pas tomber dans cette double addiction. Donc pour aider le patient on utilise d'abord, on introduit une benzodésipine à demi-vie longue et après on va commencer à diminuer progressivement les doses de façon dégressive.

Pour le sevrage thérapeutique des benzodésipines si le patient est déjà sous une benzodésipine à demi-vie longue, on va diminuer la dégression des doses en respectant les règles que vous allez voir dans le cours des benzodésipines des anxiolytiques. Si le patient est sous une benzodésipine à demi-vie courte, on va introduire une benzodésipine à demi-vie longue et on commence la dégression progressive. On peut mettre le patient sous des paquets comprimés matin et soir en cas d'antécédent de crise d'épilepsie parce que si on fait un arrêt de benzodésipine ou bien si on commence la dégression on risque de créer chez le patient des crises d'épilepsie, surtout s'il a des antécédents de crise d'épilepsie.

Pour le sevrage thérapeutique des opiacés, alors je le répète il n'y a pas de traitement spécifique pour les produits toxiques. Là pour les opiacés on fait aussi des traitements symptomatiques. On va aider le patient avec de la tharax pour diminuer l'angoisse pour l'apaiser, pour diminuer sa tension, pour améliorer son sommeil.

De la théralène aussi pour le sommeil. Viciragine, du Spasfon, du Doliprane c'est pour les douleurs. On a vu avec les opiacés on a des douleurs intenses, abdominales, lombaires des douleurs très intenses.

Et si on n'arrive pas à diminuer l'anxiété par de la tharax on peut mettre aussi des neuroleptiques sédatifs type Tertium ou Nosinon. Pour la cocaïne, donc il y a des études qui ont montré l'intérêt de Mycomas qui est un fluidifiant donc à la dose de 200 mg de sachet le matin le matin, le midi et le soir pendant 3 semaines. On peut utiliser aussi des traitements symptomatiques de la tharax pour le sommeil et l'anxiété de la théralène pour le sommeil et il y a des études qui ont montré l'intérêt d'un neuroleptique de 3ème génération l'Aripiprazole commercialisé sous le nom de l'Abilify dont ce type d'addiction à la cocaïne.

(48:03 - 48:33)

Aucune prise en charge ni arrêt de la prise de toxiques ne peut aboutir sans demande du patient et une implication totale de celui-ci. Mais bien sûr, il faut l'aider. On a plusieurs intervenants pour aider le patient et il y a l'intervention des médecins généralistes, spécialistes des centres ambulatoires, des centres d'addictologie médecins de travail, la justice, les travailleurs sociaux et le groupe d'entraide.

(48:33 - 48:59)

Il y a l'implication du sujet lui-même, du conjoint de la famille et des différents intervenants qui vont le traiter. Le moyen le plus utilisé dans les addictions c'est ce qu'on appelle la thérapie motivationnelle. Ça commence par une information objective et non biaisée sur l'état de santé et la situation personnelle.

(49:00 - 49:25)

Il faut donner des informations correctes, des informations scientifiques avec des statistiques et bien sûr, quand on a un bilan du patient quand on examine le patient il faut donner aussi des informations non biaisées sur sa santé et sur sa situation. Il ne faut pas mentir au patient pour lui faire pleurer parce qu'après il ne va plus nous croire. Il faut un rappel de la liberté de choix et d'action.

(49:26 - 49:33)

C'est aux patients de prendre les décisions. Le choix revient au patient. On n'oblige pas le patient

à changer.

(49:34 - 49:54)

Un avis ou conseil uniquement à la demande du patient de manière professionnelle et non agressive. Donc à chaque fois qu'on veut lui donner une information à chaque fois qu'on veut lui faire quelque chose un bilan ou bien un examen bien sûr il faut demander son avis. La possibilité de traitement présentée au patient.

(49:54 - 50:21)

On lui présente toutes les possibilités qu'il y a disponibles ou dont on ne dispose pas qui existent ailleurs. Les conditions nécessaires de l'entretien et l'empathie. Il faut montrer au patient qu'on comprend sa souffrance qu'on comprend le problème qu'il va rencontrer quand il va être en sevrage ou abstinent.

(50:22 - 51:02)

Renforcer à chaque fois le sentiment d'efficacité avant le sevrage et surtout à long terme. Encourager à chaque fois le patient à chaque fois qu'il fait un pas positif donc il faut l'encourager et à chaque fois lui rappeler les expériences positives qu'il a eues avec les antécédents d'abstinence. On utilise dans cet entretien ce qu'on appelle la balance décisionnelle et le modèle de stade de changement de Prochazka.

(51:03 - 51:26)

Alors la balance décisionnelle on donne au patient une feuille qu'il va partager par 4 où il va écrire dans une colonne les avantages à consommer. Là on a pris l'exemple du tabac. Là on a les désavantages à consommer les avantages à arrêter les désavantages à arrêter.

(51:27 - 51:54)

Et bien sûr il va les remplir. Bien sûr au début il ne va y avoir que des avantages à consommer. La colonne des inconvénients va être vide mais au fur et à mesure de la thérapie on va voir que la balance va changer donc on va avoir la colonne des avantages qui va diminuer et la colonne des inconvénients qui va augmenter.

(51:58 - 52:20)

Le deuxième modèle, c'est le modèle de changement de Prochazka. Le patient, lors d'une addiction il va passer par plusieurs étapes avant d'arriver à l'abstinence. Le premier stade c'est le stade d'indétermination.

(52:21 - 52:46)

La personne n'a pas encore considéré son problème comme étant un problème ou alors il le considère sans importance. Il va vous dire par exemple, surtout chez les adolescents le cannabis ne me pose aucun problème c'est ma mère qui trouve que je fume trop. Alors à ce stade là il faut essayer d'augmenter sa conscience du problème et la possibilité de changer.

(52:48 - 53:10)

Par des questions ouvertes, essayez de semer le doute chez le patient. Et il ne faut pas bien sûr à ce stade là donner des prescriptions. Le stade 2 c'est le stade d'intention plus ou moins conscient du problème avec une reconnaissance de l'existence du problème et de son importance.

(53:10 - 53:30)

Mais il y a une ambivalence aller et venir entre les raisons pour changer et les raisons pour rester les mêmes. Je me dis parfois qu'il faudrait que j'arrête le cannabis mais j'ai du mal à m'imaginer sans fumer c'est la seule chose qui me fait vraiment plaisir. Donc à ce stade là aider le patient à trancher.

(53:31 - 53:49)

Donc la perception d'inconvénients dans la situation actuelle peut générer une envie de changement Et là on va utiliser la balance décisionnelle. Le troisième stade c'est le stade de détermination. Fenêtre ouverte sur une action possible.

(53:50 - 54:00)

Planification pour un changement et en cours. Là je dois réellement faire quelque chose. Ce qui s'est passé dernièrement me fait vraiment peur et il faut que j'arrête.

(54:01 - 54:34)

Alors là le patient est déterminé à arrêter mais ce n'est pas encore décidé à 100%. Là il commence à réfléchir et surtout il a vu vraiment les conséquences des effets négatifs. Alors là des conseils à la demande et en fonction des besoins du patient avec prise de rendez-vous des ordonnances et des rendez-vous chez le psychologue et essayer de commencer avec lui la psychothérapie.

(54:36 - 54:46)

Le stade 3 c'est le stade d'action. La mise en œuvre du plan de changement. Je suis content d'avoir pu réduire ma consommation de cannabis.

(54:46 - 54:55)

Je suis beaucoup mieux depuis que je ne fume plus. Là le patient a déjà commencé à arrêter. Donc il faut un renforcement positif.

(54:55 - 55:10)

Encourager ce qu'il a fait et insister sur cette expérience positive. Le stade 5 c'est le stade de maintien d'action. Le stade de consolidation.

(55:11 - 55:24)

Maintien du changement qui s'installe dans la durée. C'est encore difficile de ne plus consommer du cannabis mais ça va de mieux en mieux. J'ai l'impression de commencer une nouvelle vie.

(55:25 - 55:43)

Là toujours le renforcement positif et aider le patient à prendre conscience des effets et des avantages de l'arrêt. Et comme vous voyez ici, il y a un stade de rechute. La rechute fait partie du cycle thérapeutique.

(55:44 - 55:54)

Là la rechute ramène le sujet vers un stade antérieur. Le plus souvent celui de la contemplation. Je me suis dit juste un petit joie.

(55:55 - 56:19)

La vie était triste sans cannabis. Là il faut rassurer le patient. Lui expliquer les différents stades et lui dire s'il rechute, on est là pour revoir avec lui les causes de la rechute, qu'est-ce qui s'est passé et essayer de corriger, essayer de l'aider.

(56:23 - 56:52)

Là on résume les différents stades. La psychothérapie de soutien elle est faite par les psychiatres, par les psychothérapeutes, les spécialistes, les médecins généralistes. Et bien sûr, il faut une préparation à une thérapie structurée avec maintien de la compléxité au traitement et un renforcement de la motivation à chaque fois.

(56:54 - 57:32)

On peut utiliser aussi la thérapie cognitivo-comportementale pour corriger, chercher d'abord les fausses croyances et les corriger et évaluer le comportement à partir d'un carnet. Aider le patient aussi dans le cadre d'une thérapie de groupe par des thérapies d'affirmation de soi parce qu'après l'abstinence, les sujets addicts ont du mal à dire non quand on leur propose la substance. Par exemple, un alcoolique dans une fête a du mal à dire non quand on lui propose un verre.

(57:32 - 57:48)

Donc on va faire avec lui les thérapies d'affirmation de soi pour dire non. La gestion des émotions, les sujets qui ont du mal à gérer leurs émotions peuvent tomber dans la rechute. Et bien sûr, tout ça pour prévenir les rechutes.

(57:50 - 58:02)

Véhiculer des messages corrects notamment l'usage de drogue est toujours risqué. Si vous ne voulez pas prendre de risque, ne consommez pas de drogue. Ne conduisez pas lorsque vous êtes sous l'effet de drogue.

(58:02 - 58:12)

Si vous vous sentez déprimé, ne consommez pas de cannabis. Ce n'est pas ça qui va vous soulager, qui va traiter votre dépression. On a vu que le cannabis est dépressogène.

(58:12 - 58:26)

Ça va aggraver votre dépression. Ne consommez pas de cannabis si vous devez étudier. Donc il y a des étudiants qui le prennent parce qu'ils ont cette impression qu'il va augmenter leur capacité de concentration, de mémoire, d'attention.

(58:26 - 58:42)

Ça donne un faux sentiment d'améliorer la mémoire et la concentration. Mais après, il va donner un effet inverse. On a vu qu'en aiguë, il donne des troubles de concentration, de mémoire et d'attention.

(58:43 - 58:59)

Et à long terme, il va donner le syndrome amésoviationnel. La possibilité d'éliminer totalement les drogues reste un mythe. On s'oriente actuellement vers la réduction des risques.

(59:02 - 59:18)

La rechute est toujours là. C'est pour ça qu'il faut être là pour dire aux patients qu'on est là si jamais ils rechutent. On ne va pas fermer les portes mais on va commencer avec lui la thérapie.

(59:23 - 59:40)

Les conséquences sont graves sur la santé physique, mentale et sociale. Les addictions restent un problème de santé publique et le meilleur traitement, c'est la prévention. Je vous remercie.